

Psychologie de la prescription

Dr SEGHIR

I. Introduction

Les démarches médicales s'articulent le plus souvent autour de la prescription médicamenteuse et l'ordonnance est la réponse la plus fréquente aux interrogations du patient.

La prescription médicamenteuse est, Cependant, un acte complexe qui dépend du médecin, du patient, du symptôme, du médicament et du cadre légal.

La prescription est l'acte par lequel un professionnel de la santé ordonne des recommandations thérapeutiques auprès d'un patient.

C'est l'application du plan thérapeutique proposé par un médecin, élaboré selon son diagnostic et les données de la médecine moderne.

II. Déroulement de la prescription

L'Organisation mondiale de la santé propose une méthode en 6 étapes comme stratégie pour le choix du traitement :

1. Evaluer et définir le problème du patient

Il s'agit initialement de clarifier si le patient présente une maladie nécessitant un traitement ou s'il vient chercher une prescription, s'il y a une anxiété ou un problème social sous-jacent, s'il s'agit d'un effet secondaire d'un médicament, s'il s'agit d'une non-adhésion au traitement ou d'une demande d'un traitement préventif.

2. Spécifier l'objectif thérapeutique

Il s'agit clarifier le but d'un traitement avec le patient avant de prescrire un médicament. Ce que le patient attend d'une prescription peut être différent des objectifs thérapeutiques du médecin.

3. Choisir le traitement approprié

Ce dernier doit être efficace, adéquat et économique.

L'OMS recommande au médecin de définir sa propre liste personnelle de médicaments (P(ersonnal)-drugs). Les P-drugs devraient être des médicaments efficaces, avantageux, bien tolérés, que le médecin a l'habitude de prescrire et dont il connaît aussi bien les effets bénéfiques, les effets secondaires que les interactions.

Prendre en compte les propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques des médicaments prescrits vérifier les interactions médicamenteuses.

Prendre en compte les croyances et représentations du patient, afin d'assurer une adhésion thérapeutique au médicament envisagé. Cette discussion est aussi importante que le choix du médicament d'un point de vue pharmacologique car elle prend en compte les préjugés, attentes, craintes du patient envers le traitement proposé.

4. Ecrire l'ordonnance

De façon lisible et précise, comportant toutes les informations utiles. Les ordonnances présentent un grand nombre d'imprécisions, peuvent conduire à des problèmes médicaux comme l'absence d'indication quant à la quantité et la durée prévue de la prescription.

5. Donner les informations, explications et avertissements nécessaires

Il s'agit des instructions et informations afin de lui en faciliter l'usage et concernant :

- Raison du traitement
- Effets secondaires
- Instructions de prise
- Avertissements : quand ne pas prendre le médicament, quelle est la dose maximale
- Suivi : quand reconsulter
- Vérifier la compréhension du patient

6. Evaluer le traitement régulièrement

En moyenne, un patient sur deux a des difficultés à suivre son traitement, il faut, dans ce cas, un apprentissage des outils de communication comme la reformulation et l'analyse de la situation.

III. Statut du médicament

Dans la prescription, le médicament peut revêtir plusieurs statuts :

- Celui d'objet transitionnel : c.à.d qu'il rend le trouble concret alors qu'il était imprécis et dissimulé. Il témoigne de la maladie
- Celui d'objet de projection : c.à.d sur lequel vont se focaliser et se projeter les affects et les conflits du patient.
- Celui d'un représentant symbolique du thérapeute et des relations entretenues avec lui.
- Celui d'un objet contraphobique : tant pour le médecin que pour le patient et sa famille.
- Celui d'un objet symbolique : beaucoup de médicaments sont investis de fonctions thérapeutiques qui s'attachent plus à des croyances qu'à des réalités.

IV. La prescription comme un élément de langage dans la relation médecin-malade

Le médicament est un élément de négociation, de communication entre le patient (avec ses représentations imaginaires du médecin, de son corps, de la maladie) et le thérapeute.

Prendre ou ne pas prendre son médicament (ou ne prendre qu'une partie de son traitement), c'est vouloir dire quelque chose, c'est signifier quelque chose au médecin.

L'observance est considérée comme le résultat d'un compromis : entre savoir et ignorance, entre soumission et déni. Quand le patient n'est pas compliant dans son traitement, cela peut signifier un refus de savoir, une tentative de réappropriation du corps malade ou une recherche d'un espace de liberté.